

Réanimation

Dr.KHERBA_N

RÉANIMATION

Accident de la voie publique AVP

Arrêt cardio respiratoire

Choc anaphylactique

Électrisation

Envenimation scorpionique

État de choc

État d'ivresse

Ingestion de Tabac à chiquer

Intoxication à la vitamine D

Intoxication au CO

Noyade

Œdème de Quincke

Overdose Cocaïne

Overdose Prégabaline

Polytraumatisme

Surdosage Furozal

Surdosage Isoptyl

Surdosage Paracétamol

Syndrome malin des neuroleptiques

Accident de la voie publique AVP

- Examen clinique complet
- Glasgow <8 : Réanimation
- Bilan pré op

- Rx :
- Des points d'impact
- Crâne
- Rachis
- Bassin
- 2 Fémurs
- ASP
- TLT
- ECG
- Échographie AP
- TDM cervico cérébrale

- 2VVP
- Scope : TA, FC, FR, SaO2
- Dextro
- Suture des plaies
- Examens complémentaires selon la clinique
- Avis spécialisés

Arrêt cardio respiratoire

- Inconscience, pas de respiration
- Abolition du pouls :

Adulte : fémoral, carotidien..

Nourrisson : brachial

 En urgence :

- Victime en position dorsale
- Libérer les VAS
- Tête en hyperextension si y pas de traumatisme de rachis
- Massage cardiaque : 100_120/min => 2 insufflations pour 30 compressions
- Adrénaline 1mg en IVD à renouveler chaque 3min

■ Enfant 🧒 : 0.01mg/kg

Adrénaline 10Ug/kg

Amiodarone 5mg/kg

CEE 4j/kg

Ou en IVL (ou en intratrachéale) 3mg dans 10cc de SSI9 puis 10mg/h en IVSE si récupération

En cas d'intubation : 5Ug/kg chez enfant

3_5mg dans 5_10cc de SSI

■ Enfant 🧒 : Adrénaline

<15 kg : 0.01mg en Sc

15_30kg : 0.15mg en Sc

>30 kg : 0.3mg en Sc

■ Si prolongement de l'asystolie :

Atropine 1mg en IV/3min

■ Si FV ou TV : choc électrique 200j

Si échecs : Lidocaine 1mg/kg en IV sur 2min

A renouveler chaque 3min max 3mg/kg

Ou Adrénaline 2_3mg en IVD à renouveler/3min

■ Si : TP torsade de pointe : Mg en IVD ou bolus IV de 2g puis 20mg/min en IVSE.

Si échec : choc électrique 200j

→ Hospitalisation en Réanimation

Choc anaphylactique

● Clinique :

Réaction allergique aigue

Prurit, urticaire, cyanose, dyspnée+++,
sibilants,

Tachycardie, hypotension <90mmhg, puis
collapsus, œdème facial puis généralisé.

■ Causes : aliments, médicaments, insectes..

✓ CAT : Hospitalisation

■ 2VVP/O2 à forte débit si non Intubation

■ Malade en position demi assise, jambes
surélevés

■ Monitoring

■ Remplissage SSI 9% 500ml/24h à répéter selon
TA

+ Adrénaline en IM 0.3mg

+ CTC : HHC 200mg en IVD

Ou Solumedrol 1mg/kg en IVD

+ Antihistaminique

■ Si dyspnée : O₂ 6_8l/min

+ Nébulisation avec Salbutamol 5mg

Ou Adrénaline 2mg dans 3cc de SSI même dose
que d'une crise d'asthme

■ Adrénaline 1cc dilué dans 10cc SGI

Chaque 5min 0.1cc d'Adrénaline en Sc

■ Adrénaline 1cc dilué dans 10cc de SSI

Puis 1cc de ce mélange dilué dans 10cc de SSI

■ Adrénaline 1amp 1mg diluée dans 10ml SG

On injecté 1ou 2ml en bolus IV ou 0.1mg/min
jusqu'à l'amélioration

■ Enfant 🧒 : Adrénaline

<15 kg : 0.01mg en Sc

15_30kg : 0.15mg en Sc

>30 kg : 0.3mg en Sc

■ Bilan 💧

■ FNS

■ CRP/VS

■ Ionogramme sanguin

■ Lactatémie

■ Gaz du sang

■ Tryptase

Électrisation

- Surveillance 24h
- Rechercher des lésions cutanées
- O2 thérapie
- Scope : TA, SaO2, FR, FC
- ECG : TDR
- Bilan : 
- FNS/Gly
- Urée/Creat=> IR
- Hépatique
- Troponines
- Ionogramme=> Dyskalémie : Hyperkalémie
- CPK/LDH=> Rhabdomyolyse

 CAT :

- 2VVP/O₂
- FC/FR/SaO₂/T°
- Si bilan perturbé=> Avis REA
- Si brûlures=> Soins + pansement Flammazine
+ Tulle gras
- ATB + Réhydratation + Sonde vésicale (diurèse)
- Remplissage vasculaire au SSI
- Surveillance +++

Envenimation scorpionique

Piqûre du scorpion

 CAT :

 Attention au risque de choc anaphylactique post injection de SAS

- Préparer l'Adrénaline : 0.01mg/kg, Max :
- 0.5mg pour un adulte
- 0.3mg pour un enfant
- À renouveler chaque 10min

- SAS :
- Même dose quelque soit l'âge ou poids
- Pas de CI : immunodépression, grossesse, allaitement, maladie chronique

● Stade1 :

- Surveillance pdt 4h : constantes HD
- O2 10_15min
- SAS 1amp en IM
- Bilan d'urgence

- Traitement symptomatique :
- Paracétamol 60mg/kg/j
- Xlylocaïn crème local

● Stade2 : Hospitalisation 24h

- Prodaf 1g en IVL
- SAS 1amp en IM
- En fonction des signes :
- Vomissements => Primperan 1amp en IM
- HTA : Nicardipine
- Convulsion => Gardénal

● Stades 3 : Hospitalisation en soin intensif

- PLS /O2 6_10l/min
- Intubation trachéale
- Monitoring
- SAS à renouveler après 3h si nécessaire sans dépasser 4amp
- Dobutamine : 10mg/kg/min

■ Enfant 🧒 :

- SAS 1amp en IM
- Perfalgan 15mg/kg
- Pas de CTC ni AH
- Hospitalisation + surveillance stricte
- Si : Signes généraux, sueurs, vomissements, Convulsion..

➡ Rajouter SAS en IV/2_4h

Classification clinique des Piqûres et Envenimations scorpioniques

Type de la piqure	Classe de la piqure	Manifestations cliniques	%
Piqure blanche	Classe I	Manifestations locales : Douleur, rougeur, sensation de brûlure, Fourmillements ...	91.34
Piqure avec envenimation	Classe II	Manifestations systémiques mineures : (ne mettant pas en jeu le pronostic vital) : hypersudation, fièvre, vomissements, priapisme, HTA, douleur abdominale ...	8.76
Piqure avec envenimation	Classe III	Manifestations systémiques majeures : (mettant en jeu le pronostic vital) : Cardio-vasculaires, respiratoires et neurologiques.	8.76

États de choc

● Clinique :

Hypotension sévère non spontanément réversible

Choc cardiogénique : Valvulopathies sévères, Péricardite constrictive, Tamponnade..

Choc hypovolémique : Hémorragie, déshydratation..

Choc anaphylactique : par vasodilatation

Choc septique : par vasodilatation

Signes cliniques : Tachycardie, polypnée, oligo anurie, obnubilation, confusion, coma, sueurs, pâleur, refroidissement

CAT : Hospitalisation

- Scope/O2/2VVP
- Remplissage
- Drogues cardiogéniques
- Traitement étiologique
- Choc cardiogénique : Dobutrex
- Choc hypovolémique : Noradrénaline
- Choc anaphylactique : Adrénaline

CTC/Antihistaminique, Éviction de l'allergène

- Choc septique :

Prélèvement de porte d'entrée ou Hémoculture

Antibiogramme/ATB adapté

État d'ivresse

✓ CAT :

- Déclaration
- TA / Dextro
- Bilan complet
- Alcoolémie
- O2 thérapie pdt 30 min
- Calculer le score de Cushman
- Valium 10_20 mg si : le score >7
- Réhydratation en perfusion :
 - 250 SG5% + 4g NaCl
- Vitamino thérapie :
 - B1 500 mg/j + B6 250 mg/j
- Scanner cérébral si : signe de focalisation ou bien TC

SCORE DE CUSHMAN

Consignes :

Afin de déterminer la nécessité de l'adjonction d'une benzodiazépine et sa posologie chez un patient en sevrage alcoolique, veuillez cocher les items correspondant à la situation du patient.

Items	0 points	1 point	2 points	3 points
Pouls (bpm/min)	< 80	81-100	101-120	> 120
PA systolique (mmHg)				
18-30 ans	< 125	126-135	136-145	> 145
31-50 ans	< 135	136-145	146-155	> 155
> 50 ans	< 145	146-155	156-165	> 165
Fréquence respiratoire	< 16	16-25	26-35	> 35
Agitation	Aucune	Discrète	Généralisée / Contrôlable	Généralisée / Incontrôlable
Sueurs	Aucune	Paumes	Paumes et front	Généralisées
Troubles sensoriels	Aucun	Photo-/phonophobie, prurit	Hallucinations critiquées	Hallucinations non critiquées
Tremblements	Aucun	Main uniquement	Tout le membre supérieur	Généralisés

Interprétation :

- score < 7 : état clinique contrôlé
- score 7-14 : syndrome de sevrage modéré
- score > 14 : syndrome de sevrage sévère

TOTAL : /21

Ingestion de Tabac à chiquer

 CAT :

- Hospitalisation
- VVP, Monitoring, O2 thérapie
- Gardenal si convulsions

 Appeler centre toxicologie

- Bilan : 
- Glycémie
- Ionogramme

Intoxication à la vitamine D

● Clinique:

Nausées, vomissements, douleur abdominale, constipation, perte d'appétit, faiblesse musculaire, céphalées, confusion, asthénie, sécheresse buccale, troubles rénaux (Hypercalcémie=> calculs rénaux IR / atteinte cardiaque)

Enfant: arrêt de croissance osseuse, retard de la fermeture de la fontanelle..

Éliminer une prise récente de la vitamine d

■ Rechercher: Hypercalcémie, lithiase rénale, néphrocalcinose

■ Évaluer: la fonction rénale, calciurie, calcémie..

CAT:

- Arrêt de tout apport de vitamine D
 - Réhydratation IV
 - CTC ou Biphosphinate pour limiter la résorption osseuse
-
- Si c'est alarmante:
 - Réhydratation avec du Lasilix
 - CTC
-
- En surveillant:
 - TA
 - Poids
-
- Bilan 
 - Diurèse
 - Calcémie

- Urée/Créat

- Ionogramme sanguin

- ECG

- Échographie abdominale: Rechercher des calculs rénaux

-  Lutter contre l'hypercalcémie:

- Chélateur de Ca

- Gluconate de K pour la Tachycardie

Intoxication au CO

Clinique :

Vertiges, céphalées, asthénie, nausées, troubles digestifs..

Coma inaugural réversible sous O₂

CAT : but CO < 5%

- Signes vitaux : FR, FC, TA, T°, SaO₂
- O₂ thérapie jusqu'à la disparition des symptômes (confusion, vertiges, céphalées, nausées, dyspnée, troubles visuels..) < 3%
- Gazométrie
- ECG
- TLT : OAP cardiogénique ou lésionnel

■ Bilan : 

■ FNS

■ TP/INR

■ Urée/Créat

■ BU

■ Troponines

■ Ionogramme

■ Dosage de HbCO

■ Lactates

■ CPK

■ Risques :

Rhabdomyolyse

IR

IDM

Hypoxie

Acidose

Noyade

✓ CAT :

- O₂
- 2VVP
- Intubation : si détresse respiratoire
- Lutter contre l'hypothermie
- Réhydratation
- Sondage urinaire
- TLT (OAP)
- ECG

- Bilan : 🩸
- FNS/Gly
- Urée/Créat
- Ionogramme
- Troponines
- Gazométrie

- Stade 1 : Surveillance 6h
- Stade 2 : O2 + TLT
- Stade 3 : Sonde nasogatrique + O2 + TLT
- Stade 4 : Réanimation ACR

3 EVALUER LA GRAVITE DE LA NOYADE

AQUASTRESS

Le sujet est conscient ; angoissé ; a froid Il est épuisé ; N'a pas de détresse ventilatoire

PETIT HYPOXIQUE

sujet est conscient ; angoissé ; présente des signes de détresse ventilatoire, agité

GRAND HYPOXIQUE

sujet est inconscient ; présente des signes de détresse ou d'arrêt ventilatoire ;
Ne présente pas d'arrêt circulatoire

L'ANOXIQUE

Le sujet est inconscient ; en arrêt cardio-ventilatoire

4 CONNAITRE LES PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

SAUVETAGE ET

AQUASTRESS

réchauffer en couvrant la victime ;
Rassurer ;

Libération des voies aériennes

PETIT

Libération des voies aériennes
oxygène à 15 litres/mn ;
Couvrir la victime

GRAND

Libération des voies aériennes
Insufflation d'oxygène à 15
litres/mn

Surveillance des fonctions vitales

ANOXIQUE

Libération des voies aériennes
Ventilation artificielle + massage cardiaque
externe
Surveillance



Œdème de Quincke

● Clinique :

Gonflement rapide de la peau et des muqueuses au niveau de la tête et du cou +
Fièvre + Urticaire.

🏠 En urgence :

■ O₂/TA/T°/VVP

■ Solumedrol 40mg en IVD 1mg/kg

Ou Dexa en IVD

Adrénaline dilué en IM

Après 1h si pas de réponse => HHC 200mg en IVD

+ 1amp Phenergan en IM 1_2h

CTC/6h

■ Si dyspnée : 1 séance de Nébulisation :

Adrénaline 1cc + 3cc SSI 15 min

Ou

Adrénaline 0.25_0.5mg ou 1amp en Sc ou IM
chaque 15min sans dépasser 1mg

■ Si non réponse :

→ Hospitalisation en médecine interne ou réa !

✓ Traitement de sortie :

1 Telfast cp 120mg 1cp/j le soir

2 Solupred cp 20mg 2cp/j le matin pdt 5j



Overdose Cocaïne

✓ CAT :

- Libérer les VAS
- O2 thérapie si SaO2 <94%
- Surveillance Fc/Fr/T°/TA/Dextro/SaO2
- ECG (Troubles de rythme, QT, QRS)
- Score Glasgow
- Bilan d'urgence : Ionogramme +++
 - Sonde vésicale pour la Diurèse
 - Charbon actif (10cp dans 1.5l d'eau)
- Si <2h (conscient, coopérant)
 - Si TA normale : Lasilix 40mg (diurèse forcée)
 - Si Hypotension, déshydratation :
Réhydratation 24h alternance entre SS19% et SG5%

- Si coma ou suspicion d'hypoglycémie : SG5% ou 10%

- Si convulsion : Valium

 Avis Réanimation + Surveillance

Overdose Prégabaline

 Évaluation rapide :

- Constantes hémodynamiques : Scope
 - État général du patient/conscience
 - O2/Administrer le charbon actif 1g/kg (les 2 premières heures)
 - ECG
 - Ionogramme
 - Bilan rénal
 - Réhydratation/Lavage gastrique si <1h
 - Antiémétique si vomissements
 - Valium si Convulsion...
 - Benzodiazépine si Agitation + surveillance respiratoire
 - Risque de convulsion, apnée, Tachy/Bradycardie, hypotension
-  Appeler le centre toxicologie

Polytraumatisme

● Patient atteint au moins 2 lésions dont au moins 1 menace le pronostic vital.

⊖ Règles ABCDE en préhospitalier :

- 1 Libérer les VAS
- 2 Assurer l'hémostase
- 3 Assurer l'état cardiocirculatoire
- 4 Vérifier l'état neurologique
- 5 Prévenir le risque d'hypothermie

✓ Mise en condition :

- Désobstruction VAS, collier cervicale
- O2 au masque 100%
- Point de compression si besoin
- Attelle d'immobilisation

- Couverture de survie
- Inj ATB si Fractures ouvertes

EPH

- TA/T°/Dextro/2VVP
- Respecter le rachis
- Score de Glasgow
- Rx : crâne, rachis, thorax, bassin et points d'impact
- Échographie AP
- Si hémorragie => Perfalgan ou Plasma gel

Surdosage Furozal (Lasilix)

● Risque de déshydratation et troubles ioniques (Hyponatrémie/Hypokalémie)

✓ CAT :

- VVP/Scope/Prise de TA
- Charbon actif ou Lavage gastrique si <2h
- Réhydratation : en alternant le SSI et SG selon poids
- Correction des troubles ioniques

■ ECG

■ Bilan complet :

■ Rénal/Hépatique

■ Ionogramme/2h

→ Avis Réa/Psychiatre

☎ Appeler le centre toxicologie

Surdosage Ispoptyl

- Effets secondaires cardiaques et neurologiques :

Bradycardie + troubles de conscience

- Surveillance des constantes vitales

- Scope

- Bilan général

- Lavage gastrique

- O2 thérapie

- Hydratation

 Avis Toxicologie / Avis Réanimation

Surdosage Paracétamol

✓ Hospitalisation:

- Avis Toxicologie
- Réhydratation
- Lavage gastrique si <2_4h
- Charbon active
- Surveillance de la fonction hépatique H0H4H8
- Bilan hépatique:
 - ASAT/ALAT
 - Facteur V
 - TP
- Antidote "Fluimucil" si la dose ingérée >150mg/kg
20 sachets (une boîte) dans une bouteille d'eau.
- Traitement symptomatiques si signes digestifs

■ Lendemain matin: Paracétamolémie:

Si (+): Surveillance + Antidote

Si (-): Sortie

⚠ Dose toxique en pédiatrie: 200mg/kg

Chez un adulte de 80kg: 8_10g

Syndrome malin des neuroleptiques

Clinique :

Végétatives, neuromusculaire neuropsychique

Troubles de conscience, hyperthermie grave, tachycardie, PA variable, rigidité musculaire ($\uparrow$ CPK), tremblement, incontinence, sialorrhée, Acidose métabolique, sueurs, diarrhée, nausées, vomissements, déshydratation, IR, insomnie, neuro psychique..

CAT :

- Arrêt du Traitement
- Réhydratation
- Traitement symptomatique
- Diminuer la T°
- Rechercher une IR ou une Déshydratation

Avis Réanimation

